פרוטוקול טיפול אישי: מדרקליני להחלפת חיתול מבוגרים

שילוב של מיומנות טכנית, רפואה מונעת וכבוד האדם למטפלים ובני משפחה.



NotebookLM

יותר מפעולה טכנית:
שלוש מטרות העל



כבוד ופרטיות

- שמירה על פרטיות המטופל
- מניעת מבוכה והקפדה על תקשורת נעימה



בריאות העור

- מניעת תפרחת, פטרת ופצעי לחץ
- בדיקת העור כקו הגנה ראשון



נוחות מרבית

- מניעת ריחות לא נעימים
- הבטחת סביבה נקייה ויבשה לחלוטין

NotebookLM

אינדיקציות להחלפה: מתי לפעול?



רטיבות ודליפה
כאשר החיתול רטוב מאוד או במקרה של דליפה החוצה.

זמן שגרה
כל 4 עד 6 שעות כחלק משגרה מסודרת.

יציאה צואתית
החלפה וניקוי בהקדם האפשרי וללא דיחוי.

אי-נוחות
כאשר הקשיש מרגיש או מביע אי-נוחות, או כשיש ריח חזק.

חשוב לזכור: לעולם אין לחכות 'עד שהחיתול יתמלא מאוד'. חשיפה ממושכת ללחות הורסת את העור.

NotebookLM

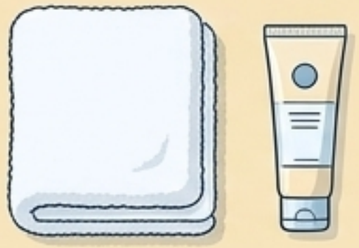
עמדת הטיפול:
היערכות מלאה מראש

הגנה



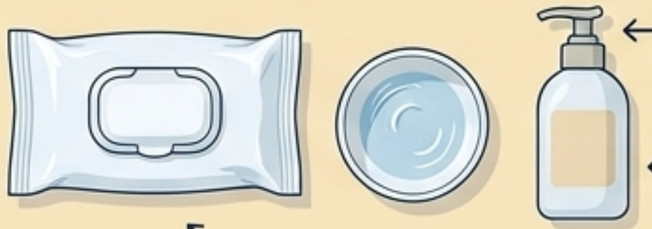
- כפפות חד-פעמיות
- משטח החתלה / סדין מגן
- שקית לפסולת

טיפוח



- מגבת קטנה ונקייה לייבוש
- קרם הגנה / קרם מחסום (לפי המלצה)

היגיינה



- מגבונים עדינים (ללא בישום) או מטליות רכות
- קערה עם מים פושרים-חמימים
- סבון עדין (רק במקרה הצורך)

הלבשה וסביבה



- חיתול נקי
- בגדים נקיים
- סדין או מגבת לכיסוי ושמירה על פרטיות

NotebookLM

חמש הדקות שלפני המגע



רחצת ידיים

חיטוי או שטיפה יסודית לפני תחילת התהליך.



תקשורת

להסביר לקשיש בנועם מה עומדים לעשות.



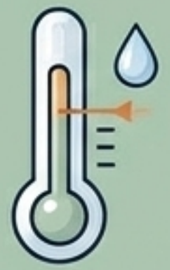
פרטיות

לסגור דלת, להסיט וילון, לכסות חלקי חלקי גוף שאינם מטופלים.



התאמת הסביבה

כוונון גובה המיטה לנוחות המטפל. הכנת כל הציוד מראש בהישג יד.



בדיקת טמפרטורה

וידוא שמי השטיפה פושרים-חמימים ונעימים לעור.

NotebookLM

התאמת הגישה למצב המטופל

מטופל סיעודי (שוכב במיטה)



- **מצב:** אינו נייד או כמעט ואינו זז.
- **שיטה:** החלפה בשכיבה, גלגול עדין הצידה.
- **דגש:** אין למשוך בידיים בלבד. תנועות איטיות.
- **בטיחות:** מטופל כבד או סובל מכאב — חובה לבצע בשניים.

מטופל בעל ניידות חלקית (עומד/יושב)



- **מצב:** מסוגל לעמוד בבטחה או לשאת מעט משקל.
- **שיטה:** החלפה בעמידה נתמכת או בישיבה על כיסא רחצה (עם פתח).
- **דגש:** עידוד שיתוף פעולה מקסימלי מצד המטופל.
- **בטיחות:** וידוא אחיזה בטוחה, נעליים מונעות החלקה, מניעת נפילות.

NotebookLM

תהליך ההסרה והניקוי (מטופל בשכיבה)

פתיחה ובידוד הלכלוך



לבישת כפפות.

פתיחת החיתול בעדינות וקיפול החלק הקדמי פנימה כדי לצמצם מגע עם העור.

ניקוי קדמי



אישה: ניקוי קפדני מלפנים לאחור בלבד.

גבר: ניקוי עדין של כל האזור, כולל קפלים וקו המפשעה.

גלגול המטופל



הטיית המטופל בעדינות הצידה.

ניקוי יסודי של הישבן, הקפלים וסביב פי הטבעת (במיוחד לאחר צואה).

סילוק בטוח



גלגול החיתול המלוכלך כלפי פנים מתחת למטופל כדי לכלוא את הלכלוך, הסרתו והשלכתו.

הסרת כפפות מלוכלכות.

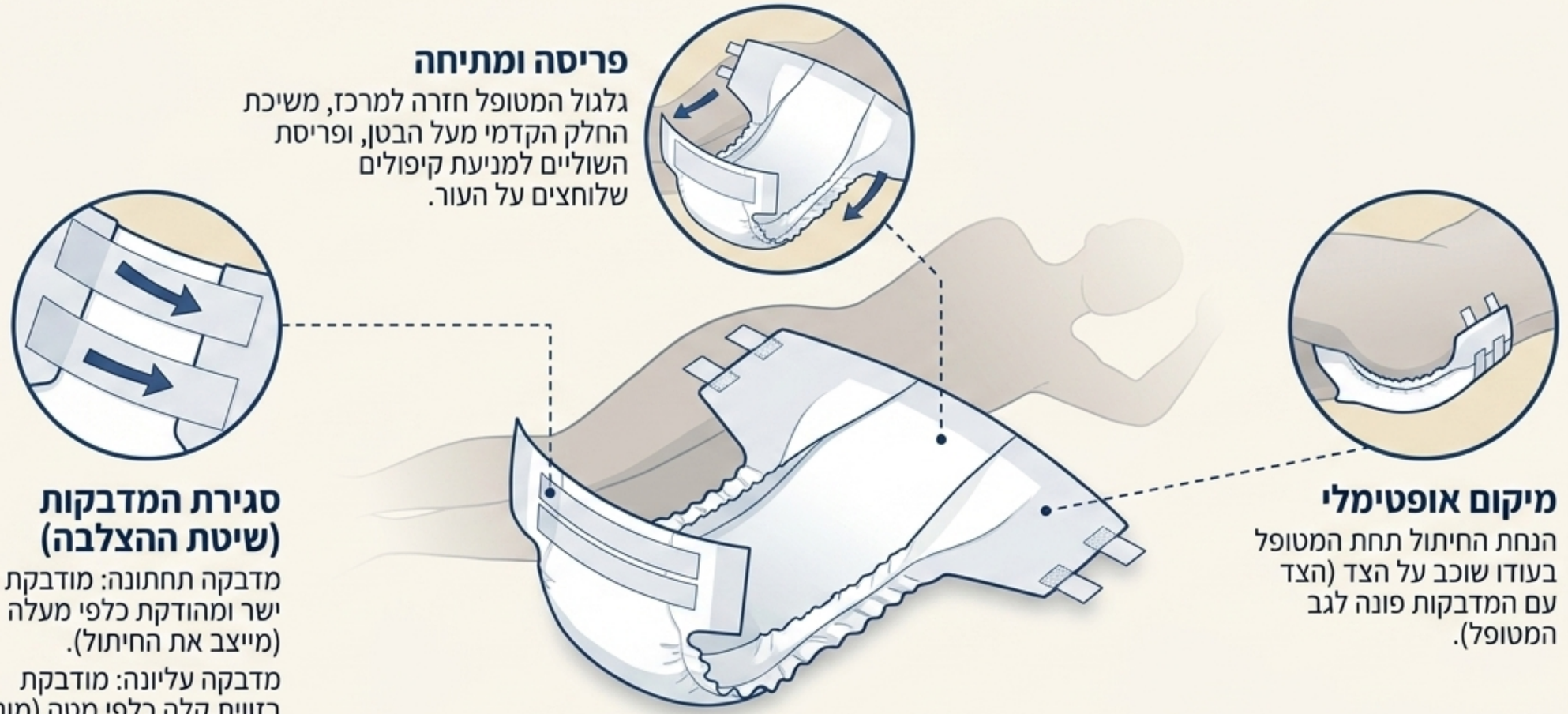
NotebookLM

מיקרו-מיומנויות: טכניקות מגע וטיפוח

פעולה	הגישה הנכונה	ממה להימנע
ניקוי	תנועות טפיחה וניגוב עדין במים פושרים ומטלית רכה.	שפשוף חזק של העור או משיכה משיכה אגרסיבית.
חומרי ניקוי	מגבונים עדינים במיוחד וללא בישום.	שימוש בסבון חריף, סבון מבושם, או שימוש שגרתי בטלק.
ייבוש	ייבוש מוחלט ומוקפד של כל קפלי העור, הישבן והמפשעה.	השארת אזורים לחים (מוביל לפטרת ותפרחת).
קרם הגנה	מריחת שכבה דקה ושקופה בלבד של קרם מחסום (לפי המלצה).	מריחת כמות גדולה ושכבה עבה שאוטמת את העור יתר על המידה.

NotebookLM

עיגון החיתול החדש



פריסה ומתיחה

גלגול המטופל חזרה למרכז, משיכת החלק הקדמי מעל הבטן, ופריסת השוליים למניעת קיפולים שלוחצים על העור.

סגירת המדבקות (שיטת ההצלבה)

מדבקה תחתונה: מודבקת בקו ישר ומהודקת כלפי מעלה (מייצב את החיתול).

מדבקה עליונה: מודבקת בזווית קלה כלפי מטה (מונע דליפות מגב תחתון).

מיקום אופטימלי

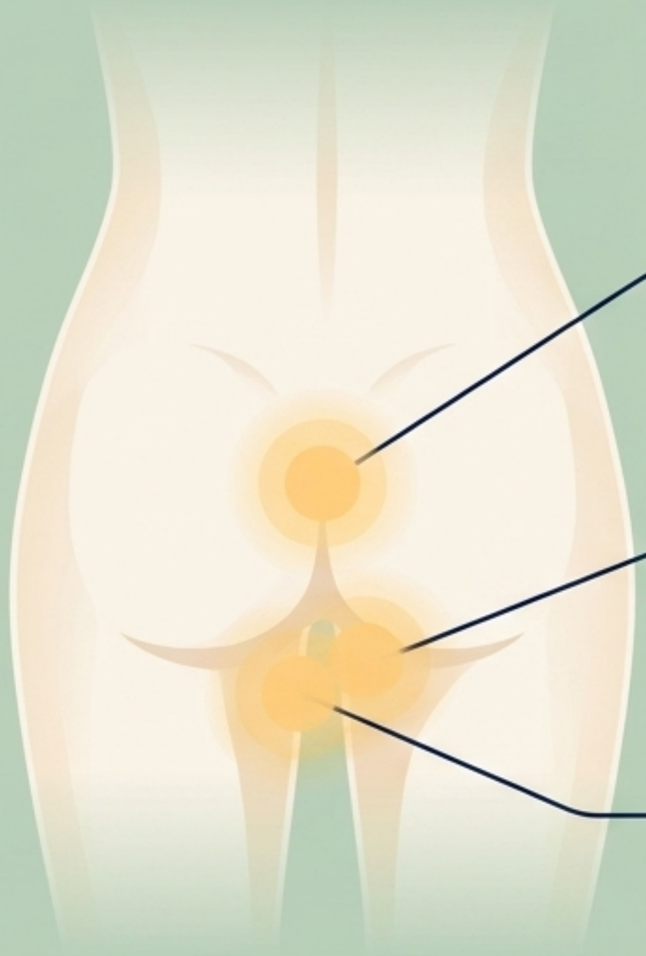
הנחת החיתול תחת המטופל בעודו שוכב על הצד (הצד עם המדבקות פונה לגב המטופל).

הערה: החיתול צריך להיות יציב אך לא הדוק מדי ולא רפוי מדי.

NotebookLM

מיפוי אנטומי: סריקת עור אקטיבית

כל החלפה היא הזדמנות למניעת פצעי לחץ וזיהומים.



עצם הזנב והישבן

סיכון גבוה לפצעי לחץ עקב שכיבה ממושכת.

קפלי מפשעה וירכיים פנימיות

מועדים לשפשופים, הצטברות לחות והתפתחות פטרת.

מתחת לבטן

אזור קפל שצובר זיעה ולחות ודורש ייבוש קפדני.

יש לוודא בכל החלפה כי שולי החיתול אינם מקופלים פנימה ואינם יוצרים לחץ נקודתי על העור.

NotebookLM

מטריצת אבחון:
מתי להמשיך בשגרה ומתי לדווח

תצפית	גורם אפשרי	פעולה נדרשת
עור לבן, לח או מקומט.	חשיפה ממושכת ללחות/שתן.	ייבוש מוקפד, הגברת תדירות החלפה, שימוש בקרם מחסום.
אודם שלא חולף, תפרחת מחמירה, פטרת.	זיהום פטרייתי, תגובה אלרגית.	דיווח לאחות/רופא להתאמת משחה טיפולית.
פצע פתוח, שלפוחית, עור מדמם, כאב במגע.	פצע לחץ בשלבי התפתחות.	דיווח מיידי! אין לעסות או לשפשף את האזור.
שלשולים חוזרים, ריח/הפרשה חריגה מאוד.	זיהום במערכת העיכול או השתן.	דיווח למשפחה/צוות רפואי לשלילת זיהום.

NotebookLM

התמודדות עם מבוכה והתנגדות והתנגדות

דיבור מסיח ומרגיע

דברו בנועם בגובה העיניים. אפשר להסיח את הדעת באמצעות שיחה על נושאים נושאים אהובים או השמעת מוזיקה מרגיעה ברקע.



צמצום החשיפה

כסו תמיד חלקי גוף עליונים שאינם מטופלים באותו רגע באמצעות מגבת או סדין. התחושה שהכל חשוף מגבירה חרדה.

ניהול התנגדות רגוע

אם יש התנגדות פיזית, לעולם אין להפעיל כוח. עצרו, נשמו, דברו ברוגע, ונסו להבין אם משהו מכאיב או מציק למטופל.

NotebookLM

רשימת תיוג יומית למטפל: לפני ואחרי

לפני ההחלפה (הכנה)

- [ ] רחצתי ידיים והכנתי את הסביבה בבטחה.
- [ ] הכנתי מראש: חיתול, כפפות, שקית, שקית, מגבונים, מגבת וקרם.
- [ ] הסברתי למטופל את הפעולה.
- [ ] וידאתי פרטיות מלאה בחדר.

אחרי ההחלפה (סיום)

- [x] ניקיתי בעדינות וייבשתי היטב את כל האזור.
- [x] סרקתי את העור וחיפשתי אדמומיות אדמומיות או פצעים.
- [x] מרחתי שכבה דקה של קרם (אם נדרש).
- [x] עיגנתי חיתול נקי בנוחות.
- [x] סידרתי את המטופל בתנוחה נוחה למניעת לחץ.
- [x] סילקתי פסולת ורחצתי ידיים.

NotebookLM